

BỆNH ÁN NỘI KHOA

DỮ LIỆU GIẢ LẬP - KHÔNG DÙNG CHO CHẨN ĐOÁN HOẶC ĐIỀU TRỊ

1 THÔNG TIN HÀNH CHÍNH

Họ và tên	NGUYỄN VĂN MINH (giả lập)	Mã bệnh nhân	DEMO-PAT-001
Năm sinh	1968 (58 tuổi)	Giới tính	Nam
Nghề nghiệp	Nhân viên văn phòng	Nhóm máu	O+
Ngày vào viện	08:20, 10/09/2026	Ngày ra viện	15:30, 13/09/2026
Khoa điều trị	Nội Tim mạch	Bác sĩ phụ trách	BS. Trần An (giả lập)

2 LÝ DO VÀO VIỆN VÀ BỆNH SỬ

Lý do vào viện: Đau tức ngực trái khi gắng sức, khó thở nhẹ và chóng mặt trong 3 ngày.

Bệnh sử: Ba ngày trước nhập viện, người bệnh xuất hiện đau tức vùng sau xương ức khi đi bộ nhanh khoảng 200 - 300 m. Cơn kéo dài 5 - 10 phút, giảm khi nghỉ, đôi lúc lan nhẹ lên vai trái. Sáng ngày nhập viện, đau tái diễn khi leo một tầng cầu thang, kèm khó thở, vã mồ hôi nhẹ và chóng mặt. Không ngất, không sốt, không ho, không đau kiểu xé lan ra sau lưng. Người bệnh tự nghỉ tại nhà, chưa dùng nitroglycerin, sau đó đến khoa Cấp cứu theo lời khuyên của gia đình.

Diễn biến tại Cấp cứu: Tỉnh táo, giao tiếp tốt, đau ngực mức 3/10 khi đến viện và hết sau nghỉ. Điện tâm đồ chưa ghi nhận ST chênh lên. Troponin hs lần 1 và lần 2 không tăng. Người bệnh được theo dõi tim mạch, kiểm soát huyết áp và làm thêm siêu âm tim, nghiệm pháp gắng sức.

3 TIỀN SỬ VÀ YẾU TỐ NGUY CƠ

Nhóm	Thông tin ghi nhận
Bản thân	Tăng huyết áp 8 năm; rối loạn lipid máu 3 năm; gan nhiễm mỡ độ 1. Chưa ghi nhận đái tháo đường.
Thuốc trước viện	Amlodipine 5 mg sáng; atorvastatin 10 mg tối nhưng dùng không đều, thường quên 2 - 3 liều/tuần.
Dị ứng	Chưa ghi nhận dị ứng thuốc hoặc thức ăn.
Phẫu thuật	Cắt ruột thừa năm 1995, hậu phẫu ổn định.
Gia đình	Cha bị nhồi máu cơ tim lúc 62 tuổi; mẹ tăng huyết áp và đái tháo đường type 2.
Lối sống	Hút khoảng 10 điếu/ngày trong 25 năm; uống bia 3 - 4 lần/tuần; ít vận động; thường ăn mặn.

4 KHÁM LÚC NHẬP VIỆN

Mạch	86 lần/phút, đều	Huyết áp	158/94 mmHg
Nhiệt độ	36,8°C	SpO2	97% khí phòng
Nhịp thở	19 lần/phút	BMI	27,4 kg/m ²

Cơ quan	Kết quả khám
Toàn thân	Tĩnh, tiếp xúc tốt; da niêm hồng; không phù; không tím; không dấu mắt nước.
Tim mạch	Lồng ngực cân đối; T1, T2 rõ; nhịp đều; chưa nghe âm thổi; mạch ngoại vi bắt rõ hai bên.
Hô hấp	Thông khí hai phế trường tốt; không ran; không co kéo cơ hô hấp phụ.
Tiêu hóa	Bụng mềm, không chướng, gan lách không sờ thấy, không phản ứng thành bụng.
Thần kinh	Glasgow 15 điểm; không yếu liệt khu trú; không rối loạn ngôn ngữ.

5

CẬN LÂM SÀNG

Huyết học và sinh hóa ngày 10/09/2026

Xét nghiệm	Kết quả	Khoảng tham chiếu	Nhận xét
Hemoglobin	14,7 g/dL	13,0 - 17,0	Bình thường
Bạch cầu	7,8 G/L	4,0 - 10,0	Bình thường
Tiểu cầu	256 G/L	150 - 450	Bình thường
Glucose đói	6,2 mmol/L	3,9 - 5,5	Tăng nhẹ
HbA1c	6,0%	< 5,7%	Tiền đái tháo đường
Creatinine	92 µmol/L	62 - 106	Bình thường
eGFR	82 mL/phút/1,73m ²	>= 60	Chức năng thận bảo tồn
AST / ALT	31 / 42 U/L	< 40 / < 41	ALT tăng rất nhẹ
LDL-C	4,10 mmol/L	Mục tiêu tùy nguy cơ	Tăng
HDL-C	0,95 mmol/L	> 1,0	Giảm nhẹ
Triglyceride	2,05 mmol/L	< 1,7	Tăng
Troponin hs	7 và 8 ng/L	< 14	Không tăng động học

Thăm dò chức năng và hình ảnh

Thăm dò	Kết quả
Điện tâm đồ	Nhịp xoang 82 lần/phút, trục tim bình thường, không ST chênh lên, thay đổi ST-T không đặc hiệu ở DII, DIII, aVF.
X-quang ngực	Bóng tim không lớn, phổi không thâm nhiễm, không tràn dịch màng phổi.
Siêu âm tim	EF 62%; kích thước buồng tim trong giới hạn; không rối loạn vận động vùng; hở van hai lá nhẹ; không tràn dịch màng tim.
Nghiệm pháp gắng sức	Dương tính nghi ngờ thiếu máu cơ tim ở mức tải trung bình; xuất hiện đau ngực nhẹ và ST chênh xuống 1 mm, hồi phục sau nghỉ.

6

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐÁNH GIÁ

Mức độ	Chẩn đoán / vấn đề
Chẩn đoán chính	Đau thắt ngực ổn định nghi do bệnh động mạch vành, chưa ghi nhận hội chứng vành cấp.

Mức độ	Chẩn đoán / vấn đề
Bệnh kèm	Tăng huyết áp chưa đạt mục tiêu; rối loạn lipid máu hỗn hợp; tiền đái tháo đường; thừa cân.
Yếu tố nguy cơ	Hút thuốc lá, ít vận động, ăn mặn, tuân thủ thuốc chưa tốt, tiền sử gia đình bệnh tim mạch sớm.
Phân tầng	Nguy cơ tim mạch cao; cần đánh giá chuyên khoa và cân nhắc chụp mạch vành theo diễn biến lâm sàng.

7 ĐIỀU TRỊ TRONG VIỆN VÀ DIỄN BIẾN

Người bệnh được nghỉ ngơi, theo dõi điện tâm đồ và dấu hiệu sinh tồn; không ghi nhận cơn đau ngực kéo dài, rối loạn nhịp hoặc suy tim. Huyết áp giảm dần còn 132 - 138/78 - 84 mmHg. Men tim không tăng qua hai lần xét nghiệm. Khả năng gắng sức ổn định khi đi lại nhẹ trong buồng bệnh.

Thuốc / can thiệp	Cách dùng trong viện	Mục tiêu
Aspirin	81 mg uống mỗi sáng	Kháng kết tập tiểu cầu theo đánh giá tim mạch
Atorvastatin	40 mg uống buổi tối	Hạ LDL-C cường độ cao
Amlodipine	5 mg uống mỗi sáng	Kiểm soát huyết áp
Bisoprolol	2,5 mg uống mỗi sáng	Giảm nhịp tim và triệu chứng đau ngực
Nitroglycerin	0,5 mg ngậm dưới lưỡi khi đau ngực, tối đa theo hướng dẫn	Cất cơn; người bệnh chưa cần dùng trong viện
Tư vấn	Bỏ thuốc lá, ăn giảm muối và mỡ bão hòa, vận động theo kế hoạch	Giảm nguy cơ tim mạch lâu dài

8 ĐƠN THUỐC VÀ KẾ HOẠCH RA VIỆN

Thuốc	Liều dùng	Thời gian / lưu ý
Aspirin 81 mg	1 viên sau ăn sáng	30 ngày; báo ngay khi chảy máu bất thường
Atorvastatin 40 mg	1 viên lúc 21:00	30 ngày; theo dõi đau cơ, men gan theo hẹn
Amlodipine 5 mg	1 viên lúc 07:00	30 ngày; theo dõi huyết áp và phù chân
Bisoprolol 2,5 mg	1 viên lúc 07:00	30 ngày; không tự ngừng, theo dõi mạch
Nitroglycerin 0,5 mg	Ngậm 1 viên khi đau ngực	Nếu đau không giảm sau 5 phút, gọi cấp cứu; không tự lái xe

Dấu hiệu phải cấp cứu: đau ngực khi nghỉ hoặc kéo dài trên 5 phút; đau tăng dần; khó thở; vã mồ hôi; ngất; yếu liệt; nói khó. Gọi cấp cứu và không tự lái xe đến bệnh viện.

Lịch tái khám: Chuyên khoa Tim mạch sau 7 ngày; khám sớm hơn nếu triệu chứng tái phát. Mang theo nhật ký huyết áp, mạch và danh sách thời điểm đau ngực.

Xét nghiệm theo dõi: Lipid máu, AST/ALT sau 6 - 8 tuần; glucose đói và HbA1c sau 3 tháng; đánh giá thêm động mạch vành theo chỉ định bác sĩ Tim mạch.

Khuyến nghị lối sống: Ngừng hoàn toàn thuốc lá; hạn chế rượu bia; giảm muối; ưu tiên rau, đậu, cá, ngũ cốc nguyên hạt; đi bộ nhẹ 10 - 15 phút mỗi ngày sau khi bác sĩ cho phép và tăng dần theo khả năng.

9 TÓM TẮT RA VIỆN DO BÁC SĨ GHI

Nam 58 tuổi, tiền sử tăng huyết áp, rối loạn lipid máu, hút thuốc lá và tuân thủ thuốc chưa tốt, nhập viện vì đau ngực khi gắng sức. Hai lần troponin hs không tăng, điện tâm đồ không có ST chênh lên, siêu âm tim EF 62% không rối loạn vận động vùng. Nghiệm pháp gắng sức dương tính nghi ngờ thiếu máu cơ tim. Chẩn đoán đau thắt ngực ổn định nghi do bệnh động mạch vành, tăng huyết áp chưa đạt mục tiêu, rối loạn lipid máu hỗn hợp, tiền đái tháo đường và thừa cân. Sau điều trị nội khoa, người bệnh hết đau ngực, huyết động ổn định, được xuất viện với aspirin, statin cường độ cao, thuốc hạ áp, chẹn beta và nitroglycerin dùng khi cần. Tái khám Tim mạch sau 7 ngày và đến cấp cứu nếu đau ngực kéo dài hoặc xuất hiện dấu hiệu cảnh báo.

Người bệnh / Người đại diện

Nguyễn Văn Minh (giả lập)

Đã được giải thích kế hoạch theo dõi

Bác sĩ điều trị

BS. Trần An (giả lập)

Ký điện tử: DEMO-SIGN-001

Gợi ý kiểm thử AI: trích xuất chẩn đoán chính và bệnh kèm; nhận diện yếu tố nguy cơ; tóm tắt xét nghiệm bất thường; liệt kê thuốc ra viện; phát hiện kế hoạch tái khám và dấu hiệu cảnh báo.